

17. L'OCCHIO E IL MOVIMENTO DI CORTICALIZZAZIONE

DURATA : 08:22

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora il legame dinamico tra l'occhio e il movimento di corticalizzazione nello sviluppo del cervello. Viene esaminato il processo di flessione cefalica e cervicale, nonché la riorganizzazione dei tessuti cerebrali in relazione alle strutture facciali e viscerali. L'occhio è presentato come un attore centrale in questo movimento, influenzando la formazione della falce cerebrale e del tentorio del cervelletto, integrando al contempo aspetti psichici ed emotivi attraverso il suo legame con il sistema ormonale. Vengono introdotti i concetti di diaframma di equilibrio e di fulcro terminale, sottolineando l'importanza della stabilizzazione della sutura cruciforme per riequilibrare gli occhi e favorire l'armonia corporea. Questa lezione offre chiavi pratiche e teoriche per i professionisti che desiderano comprendere meglio lo sviluppo embriologico e le sue implicazioni terapeutiche.

L'OCCHIO E IL MOVIMENTO DI CORTICALIZZAZIONE

Il **cervello**, inizialmente percepito come un tessuto piatto, subisce una trasformazione significativa nel corso del suo sviluppo. Immaginate un individuo sdraiato su un tavolo, con il suo cervello in mano. La prima informazione da ricordare è quella dell'**espansione** e della **formazione del tubo neurale**.

Questo processo inizia con un **movimento di flessione cefalica**, seguito da una **flessione cervicale**, poi da uno sviluppo **pontico** e da un processo di **telencefalia**. Man mano che il cervello si raddrizza, le piccole strutture seguono questo movimento di sviluppo, indicando un cambiamento di orientamento.

L'**occhio**, nella sua spirale di sviluppo, contiene l'informazione della **corticalizzazione**. Durante questo raddrizzamento, tutto il tessuto si riorganizza in un movimento di rotazione, avvicinandosi alla **linea mediana**. In basso, il tessuto tira verso il cuore e il sistema digestivo, mentre in alto si raddrizza. Questo movimento è creato dall'**ascensione del cervello** e dalla **discesa del cardio-viscerale**.

L'occhio gioca un ruolo cruciale in questo fenomeno di **corticalizzazione**, contribuendo allo sviluppo della **falce cerebrale** e del **tentorio del cervelletto**, che si inserisce sui processi clinoidei. Nelle vicinanze si trova il **chiasma ottico**, un elemento essenziale da considerare.

Un altro aspetto importante è il **diaframma dell'equilibrio** e la **capsula di Tonon**, che collega l'occhio all'intero sistema facciale e a tutte le fasce del corpo. Ciò significa che l'occhio costituisce un'**unità** integrale, contenente tutta l'informazione facciale. Riceve anche informazioni emotive e psichiche, veicolate da sostanze ormonali. Così, lo stato psichico è intrinsecamente legato a uno stato ormonale ed emotivo.

Trattare l'occhio, quindi, significa affrontare lo sviluppo sia **peritoneale**, **periferico** che **corticale**. L'occhio è in relazione con la totalità del corpo nella sua espressione e nel suo sviluppo. Ogni organo possiede il proprio punto di vista, e ogni organo è un simbolo.

Intorno al **26° giorno**, appare un **solco ottico**, legato a una connessione interna. Questo solco è stimolato da una vescicola che tocca la parete superficiale. La flessione cefalica e cervicale comporta un incontro tra il cervello e il cuore, con l'occhio che si deposita sul cuore. Questo crea una **piega posteriore**, conosciuta come **curvatura pontica**, dove si trova il sacro e il tentorio del cervelletto.

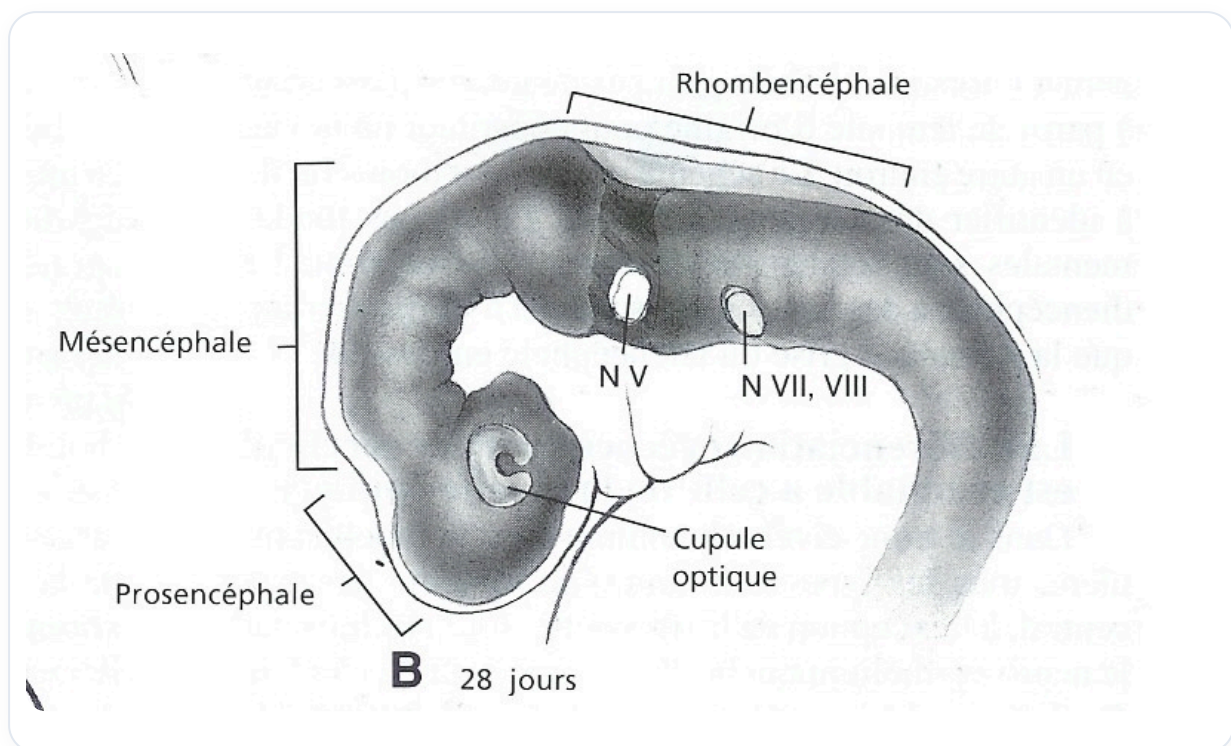


FIG. — Solco ottico e vescicola

Il **tentorio del cervelletto** è primordiale, poiché stabilisce sincronicità con il peritoneo e il cervello. La **flessura sottomesencefalica** è in rapporto con la punta della **notocorda**, fungendo da punto di appoggio. Il **sovraccipite** è anche legato alla flessione cervicale, mentre la flessura pontica è associata alla base occipitale.

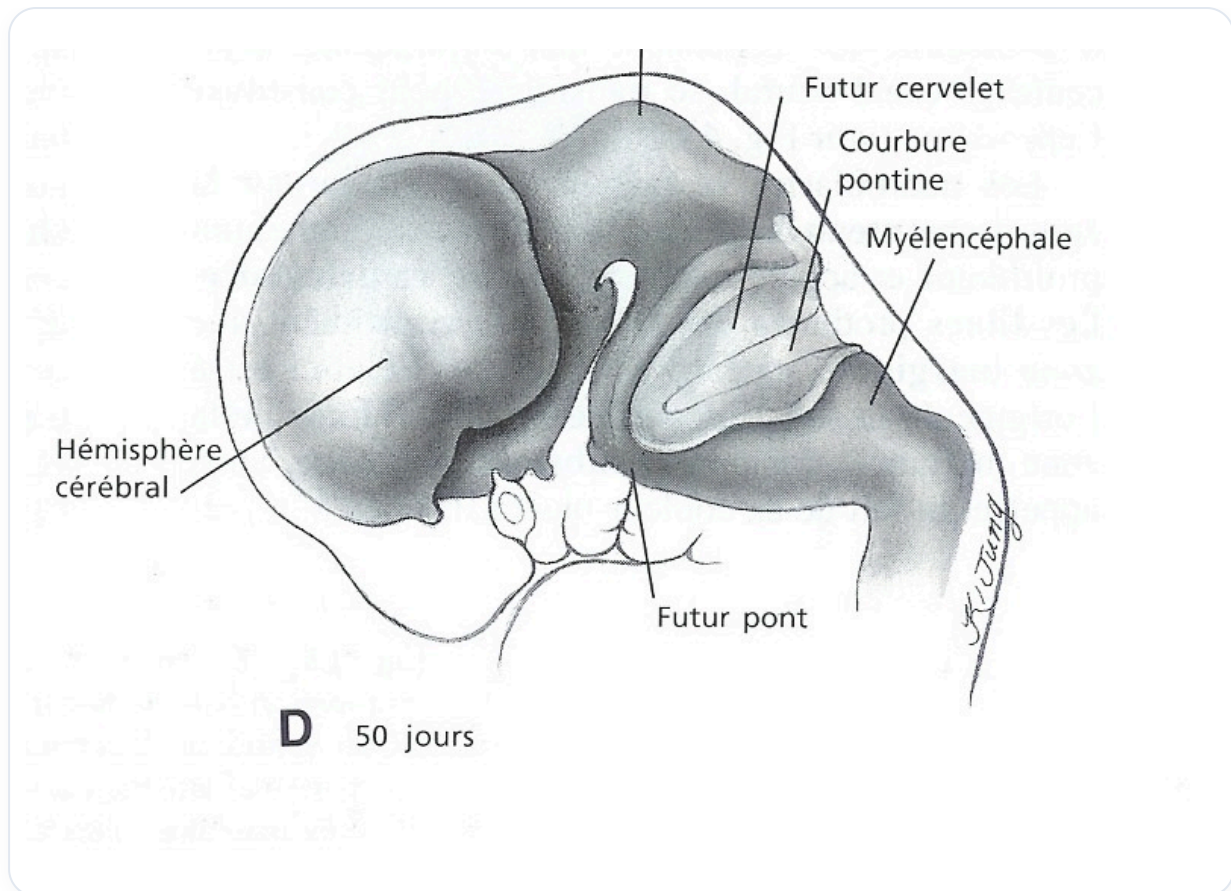


FIG. — Incontro del cervello e del cuore

L'ascensione del tubo neurale influenza lo sviluppo del sistema digestivo e cardiaco, così come altri spazi di sviluppo. Le **colocalità** e **sincronicità** durante la morfogenesi aiutano a comprendere i punti di appoggio. L'ascensione dell'**ectoderma** e la discesa dell'**endoderma** sono essenziali per l'integrazione del cervello.

L'occhio segue questa fase di sviluppo, avvicinandosi alla linea mediana per formare la **crista galli**, che riunisce le membrane per creare la falce cerebrale. Il tentorio del cervelletto si sviluppa anche durante il fenomeno di pontizzazione.

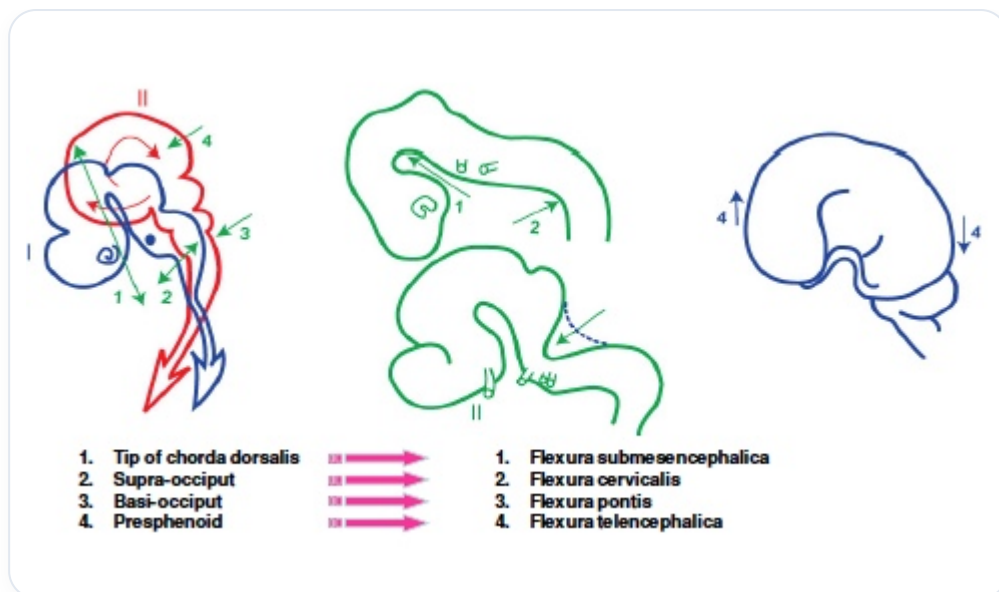


FIG. — Punti di appoggio

È cruciale notare che il punto di appoggio, o **fulcro terminale**, della messa in opera degli occhi è essenziale. Per riequilibrare gli occhi, si raccomanda di posizionare un dito in bocca, a livello della piccola **sutura cruciforme**. Ciò permette ai due occhi di trovare il loro spazio nel momento in cui questa sutura si stabilizza.

La **marginale frontale**, la **marginale zigomatica** e la **marginale mascellare superiore** sono punti di appoggio importanti. La salita e la discesa delle strutture contribuiscono alla chiusura della linea mediana, il che è anche legato alla chiusura del palato. Quando il palato trova il suo punto di appoggio, anche gli occhi trovano il loro posto, segnando un **fulcro di arrivo** nello sviluppo.